

REPETITOIRE QCM

Mathieu Nendaz et Jean-Luc Reny
Service de médecine interne générale.
Service de médecine interne et réhabilitation – 3C.
HUG. Genève

- Une femme de 79 ans est en suite de soins après un épisode d'œdème aigu du poumon ayant motivé son hospitalisation 10 jours auparavant. Une FA nouvelle avait été retrouvée et un traitement de digoxine, IEC et diurétiques avait été introduit, toujours présent actuellement.
- La patiente se sent nauséuse et ne mange plus depuis 2j. L'auscultation cardiopulmonaire est normale. L'abdomen n'est pas inquiétant à l'examen clinique.
- Quel examen est le plus indiqué ?

A.	Formule sanguine complète
B.	Albumine sanguine
C.	Digoxinémie
D.	Radiographie du thorax
E.	Gastroscopie

- Une femme de 79 ans est en suite de soins après un épisode d'œdème aigu du poumon ayant motivé son hospitalisation 10 jours auparavant. Une FA nouvelle avait été retrouvée et un traitement de digoxine, IEC et diurétiques avait été introduit, toujours présent actuellement.
- La patiente se sent nauséuse et ne mange plus depuis 2j. L'auscultation cardiopulmonaire est normale. L'abdomen n'est pas inquiétant à l'examen clinique.
- Quel examen est le plus indiqué ?

A.	Formule sanguine complète
B.	Albumine sanguine
C.	Digoxinémie
D.	Radiographie du thorax
E.	Gastroscopie

Pourquoi?

A.	Formule sanguine complète - Peu de raison- électrolytes seraient plus utiles pour hyponatrémie éventuellement
B.	Albumine sanguine - Pour état nutritionnel? Peu de raison
C.	Digoxinémie - Symptôme typique d'intoxication (+xanthochromie, +ECG)
D.	Radiographie du thorax - Peu utile pour expliquer nausées. Hernie hiatale?
E.	Gastroscopie - Peut-etre dans un 2 ^e temps si pas d'explication autre

- Une femme de 67 ans est traitée depuis 3 ans par lisinopril pour une HTA. Elle n'a jamais fumé.
- Elle se plaint depuis 5 semaines d'une toux sèche persistante, sans symptômes infectieux ou allergiques particuliers.
- L'examen physique est normal
- Une radiographie du thorax et une mesure du peak-flow sont normales
- Quelle attitude est la plus appropriée à ce stade ?

A.	CT-scanner thoracique
B.	Gastroscopie
C.	Remplacement du lisinopril par candesartan
D.	Test de stimulation bronchique à la métacholine
E.	Prescription d'opiacés comme anti-tussifs

- Une femme de 67 ans est traitée depuis 3 ans par lisinopril pour une HTA. Elle n'a jamais fumé.
- Elle se plaint depuis 5 semaines d'une toux sèche persistante, sans symptômes infectieux ou allergiques particuliers.
- L'examen physique est normal
- Une radiographie du thorax et une mesure du peak-flow sont normales
- Quelle attitude est la plus appropriée à ce stade ?

A.	CT-scanner thoracique
B.	Gastroscopie
C.	Remplacement du lisinopril par candesartan
D.	Test de stimulation bronchique à la métacholine
E.	Prescription d'opiacés comme anti-tussifs

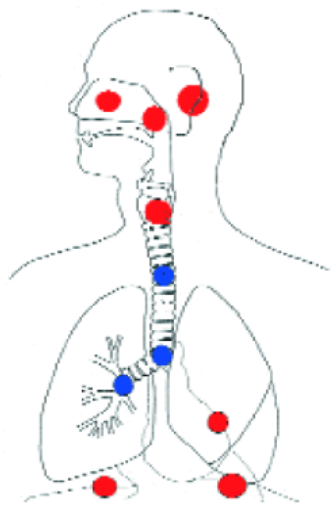


Figure 1. Représentation schématique du thorax avec localisation anatomique des récepteurs dans la sphère respiratoire (bleu), digestive et ORL (rouge) impliqués dans la physiologie de la toux : nez et oreille externe, pharynx, larynx, arbre trachéobronchique, péricarde, estomac et diaphragme (Adapté selon Irwin et coll. 7).

Tableau 2. Toux chronique : classement en étiologie fréquente et moins fréquente

Diagnostic fréquent	Diagnostic moins fréquent	Diagnostic rare
• Écoulement nasal postérieur (ENP) • Asthme bronchique • Reflux gastro-oesophagien (RGO)	• IVRS < 8 semaines • IEC • Bronchiectasies • Cancer pulmonaire • Bronchite à éosinophiles (NAEB) • Corps étranger • Pneumopathie interstitielle • Insuffisance cardiaque	• MAV • Trachéobronchomalacie • Diverticule trachéal • Irritation du canal auditif externe (corps étranger, bouchon de cérumen)

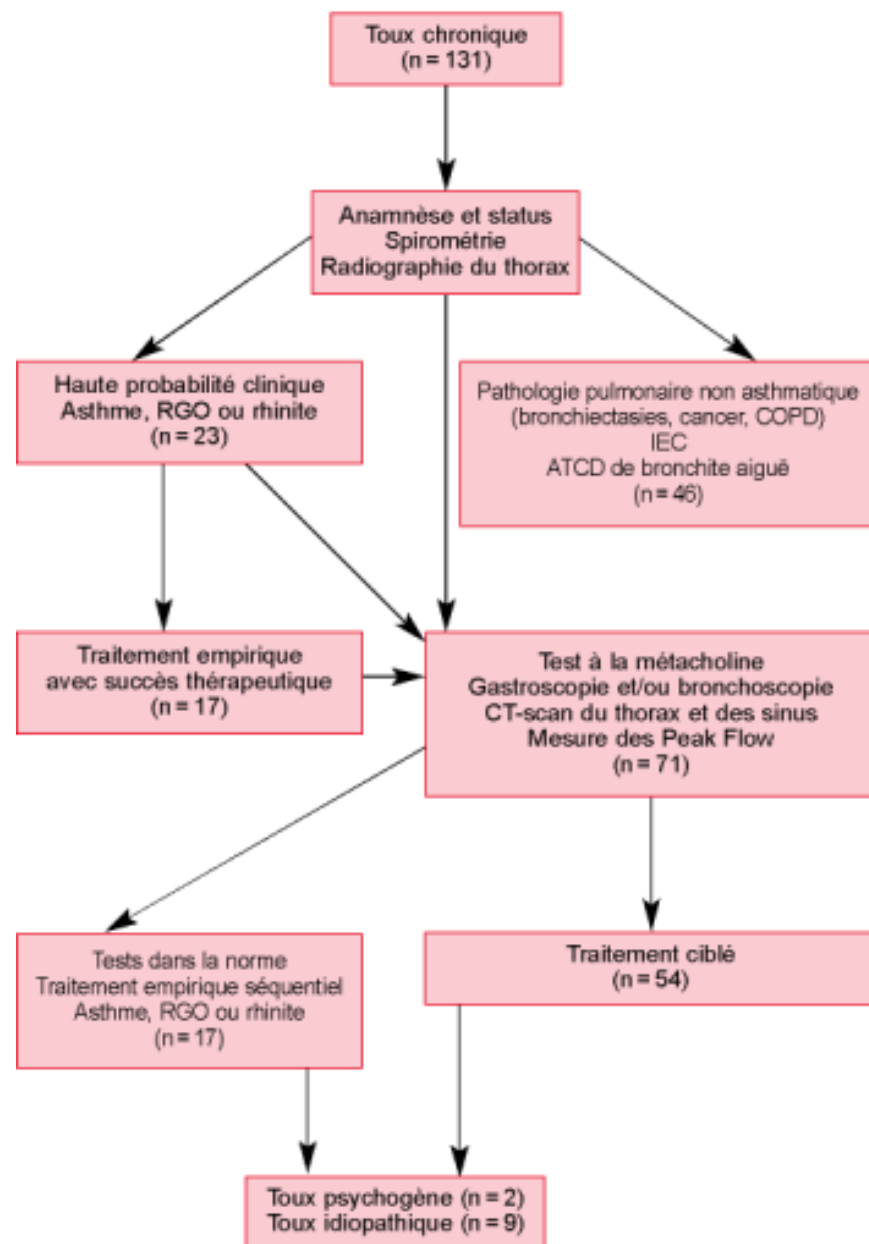
Si pas IEC, pas de tabagisme et Rx thorax normale

90% des causes sont:

- Asthme
- Écoulement postérieur
- Reflux gastro-oesophagien

TABLE 1 Questions used to ascertain the probable medical condition responsible for a patient's chronic cough

Number	Question	Weighting
1	Cough with eating (during or straight after meals)	Reflux
2	Cough with certain foods	Reflux
3	Cough when you get out of bed in the morning	Reflux
4	Cough brought on by singing or speaking (for example, on the telephone)	Reflux
5	Hoarseness or a problem with your voice	Reflux
6	Clearing your throat	Reflux
7	Cough after lying down	Reflux
8	Heartburn, chest pain, indigestion or stomach acid coming up	Reflux
9	Wheezing or chest tightness in general	Asthma
10	Cough waking you from sleep	Asthma
11	Shortness of breath when not coughing	Asthma
12	Blocked or stuffy nose	Rhinitis
13	Excess mucus in the throat, or dripping down the back of the nose	Rhinitis
14	Itchy nose and/or sneezing	Rhinitis
15	Loss of the sense of smell	Rhinitis
16	A feeling that mucus is running down the back of your throat	Rhinitis



Partie II

IM 319 nephrotic syndrome in adults 2 D

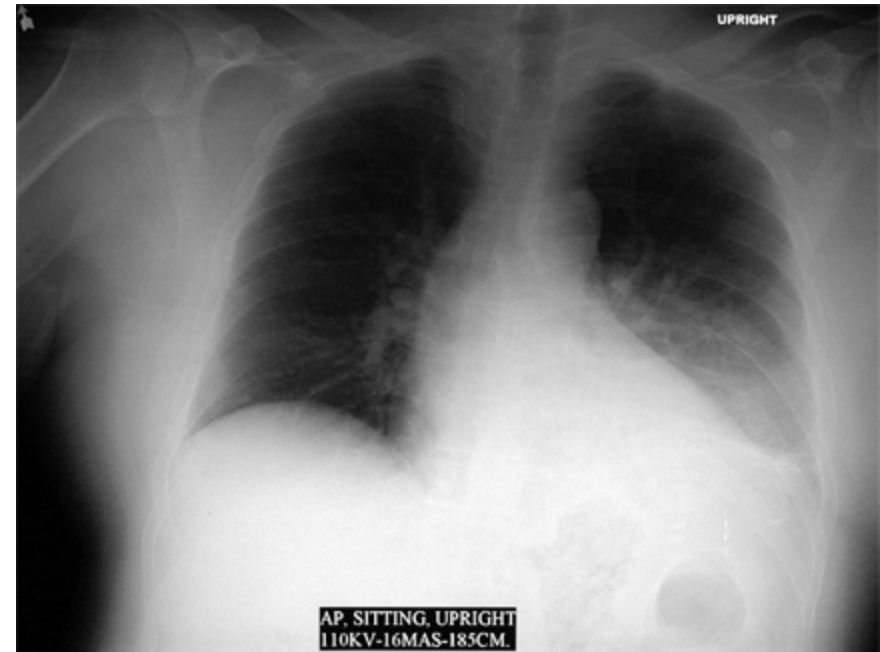
9. Un homme de 55 ans consulte pour une toux grasse évoluant depuis 7 jours.

T=38.9°C, PA=140/84 mmHg, FC=94/min, FR=20/min,

SaO₂=98% air ambiant. Râles crépitants

Quel est le traitement de première intention le plus approprié?

- | | |
|----|---------------|
| A. | Ceftriaxone |
| B. | Imipenem |
| C. | Amoxicilline |
| D. | Cotrimoxazole |
| E. | Rifampicine |



Un homme de 55 ans consulte pour une toux grasse évoluant depuis 7 jours.

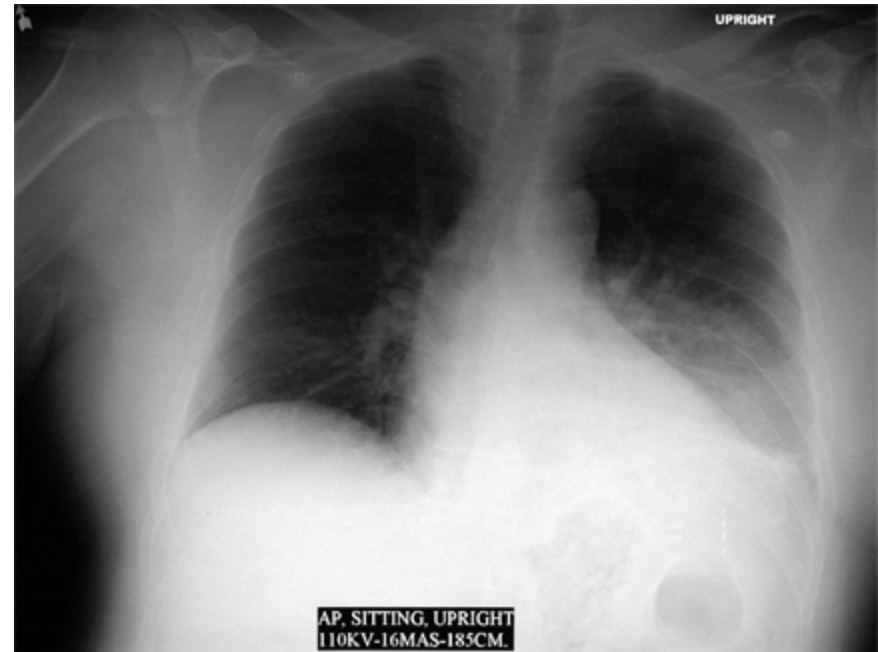
T=38.9°C, PA=140/84 mmHg, FC=94/min, FR=20/min,

SaO₂=98% air ambiant. Râles crépitants base gauche

Quel est le traitement de première intention le plus approprié?

- | | |
|----|---------------|
| A. | Ceftriaxone |
| B. | Imipenem |
| C. | Amoxicilline |
| D. | Cotrimoxazole |
| E. | Rifampicine |

HUG amoxi + ac clavulanique



IDSA/ATS guidelines: Recommended empiric antibiotics for community-acquired pneumonia in adults

Outpatient treatment

1. Previously healthy and no use of antimicrobials within the previous 3 months:

A macrolide (azithromycin, clarithromycin, or erythromycin)

OR

Doxycycline*

2. Presence of comorbidities such as chronic heart, lung, liver or renal disease; diabetes mellitus; alcoholism; malignancies; asplenia; immunosuppressing conditions or use of immunosuppressing drugs; or use of antimicrobials within the previous 3 months (in which case an alternative from a different class should be selected):

A respiratory fluoroquinolone (moxifloxacin, gemifloxacin, or levofloxacin [750 mg])

OR

A beta-lactam (first-line agents: high-dose amoxicillin, amoxicillin-clavulanate; alternative agents: ceftriaxone, cefpodoxime, or cefuroxime) **PLUS** a macrolide (azithromycin, clarithromycin, or erythromycin)*

British Thoracic Society guidelines: Initial empirical treatment regimens for community-acquired pneumonia (CAP) in adults

Pneumonia severity (based on clinical judgement supported by CURB65 severity score)	Treatment site	Preferred treatment
Low severity (eg, CURB65 = 0-1 or CRB65 score = 0, <3 percent mortality)	Home	Amoxicillin 500 mg orally three times daily
Low severity (eg, CURB65 = 0-1, <3 percent mortality) but admission indicated for reasons other than pneumonia severity (eg, social reasons/unstable comorbid illness)	Hospital	Amoxicillin 500 mg orally three times daily If oral administration not possible: amoxicillin 500 mg IV three times daily*
Moderate severity (eg, CURB65 = 2, 9 percent mortality)	Hospital	Amoxicillin 500 mg to 1 gram orally three times daily <i>plus</i> clarithromycin 500 mg orally twice daily

RECOMMANDATIONS HUG

http://medinter/library/itineraires_cliniques/Pneumonie/PAC_OFFICIEL.pdf

Si décision de traitement AMBULATOIRE	Si décision de traitement HOSPITALIER
Amoxicilline-clavulanate p.o. 3x625mg/j ou Cefuroxime p.o. 2x500mg/j	Amoxicilline-clavulanate i.v. 4x1.2g/j ou Cefuroxime i.v. 3x1500mg/j
Egalement possible selon contexte clinique : Doxycycline p.o. 2x100mg/j ou Clarithromycine 2x500mg/j	<i>Plus</i> clarithromycine p.o. ou i.v. 2x500mg/j si: - CURB 3 et plus ou - Contexte épidémiologique avec risque de Légionellose
En seconde ligne ou si allergie aux beta-lactames: Levofloxacin p.o. 2x500mg/j	Si allergie b-lactames: Levofloxacin i.v. 2x500mg/j pendant 24h puis p.o.

• Quelle gravité : CURB-65 ^{Hosp?}

Score de gravité CURB-65

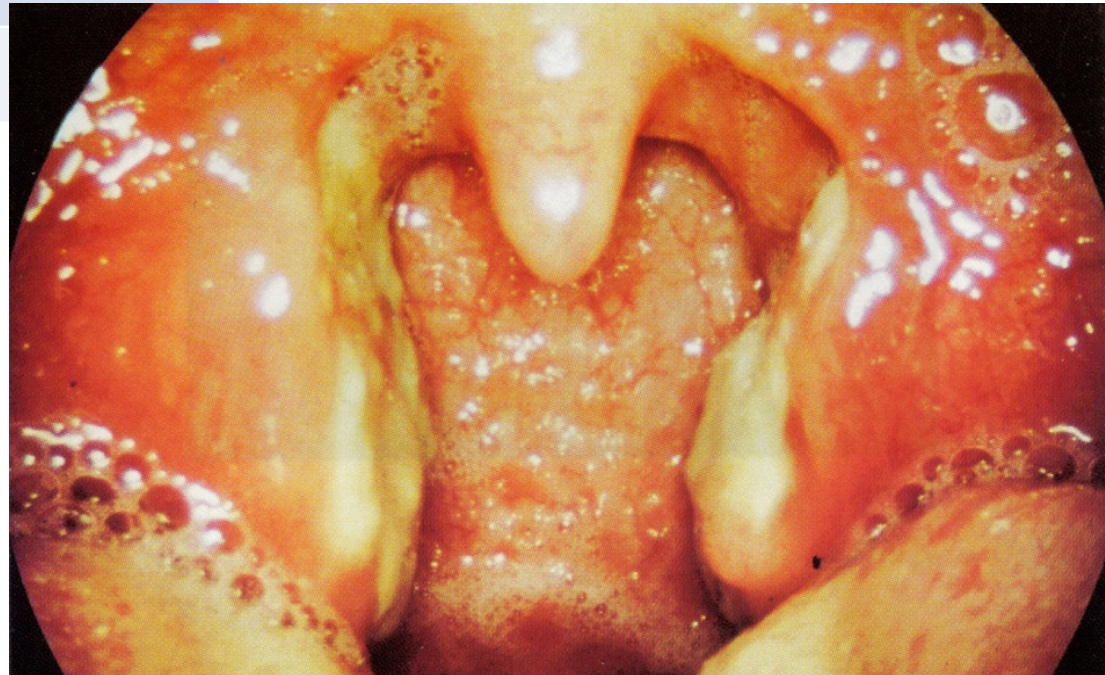
Confusion	1
Urea >7mmol/l	1
Respiratory Rate ≥ 30 /min	1
Blood Pressure (systolic <90 or diast. <60)	1
Age > 65	1

• Quels pathogènes :

- ^{amoxi.} S. pneumoniae => age, clinique, radio, « tue » ^{†, ttt rapide}
- ^{macrolide} M. pneumoniae => age, clinique, radio ^{mycoplasme}
- H. influenzae, legionnelle, pneumocystis, BK, staphylocoque : contexte epidémio-clinique ^{Patient + jeune}

10. Malgré une pénicillinothérapie d'une semaine, un homme de 24 ans présente toujours une odynophagie persistante associée à une asthénie et à une polyadénopathie cervicale bilatérale. Au vu du status pharyngé (voir figure), quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

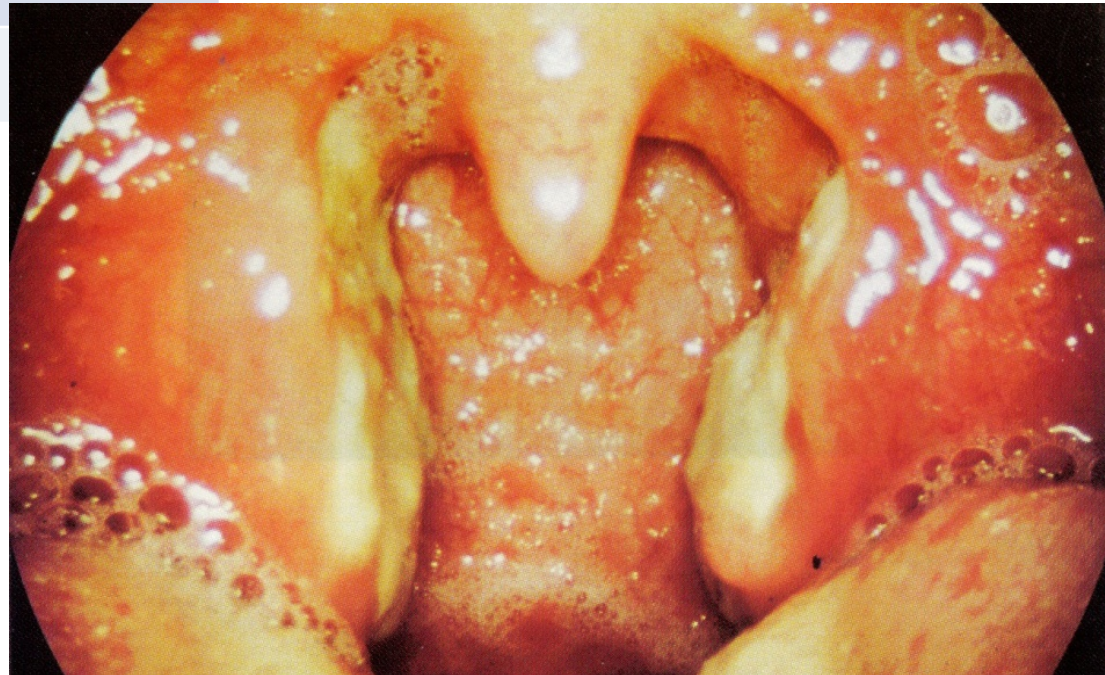
- A. une tuberculose pharyngée
- B. une angine de Plaut-Vincent
- C. une mononucléose infectieuse
- D. une angine hérpétique
- E. une pharyngite virale



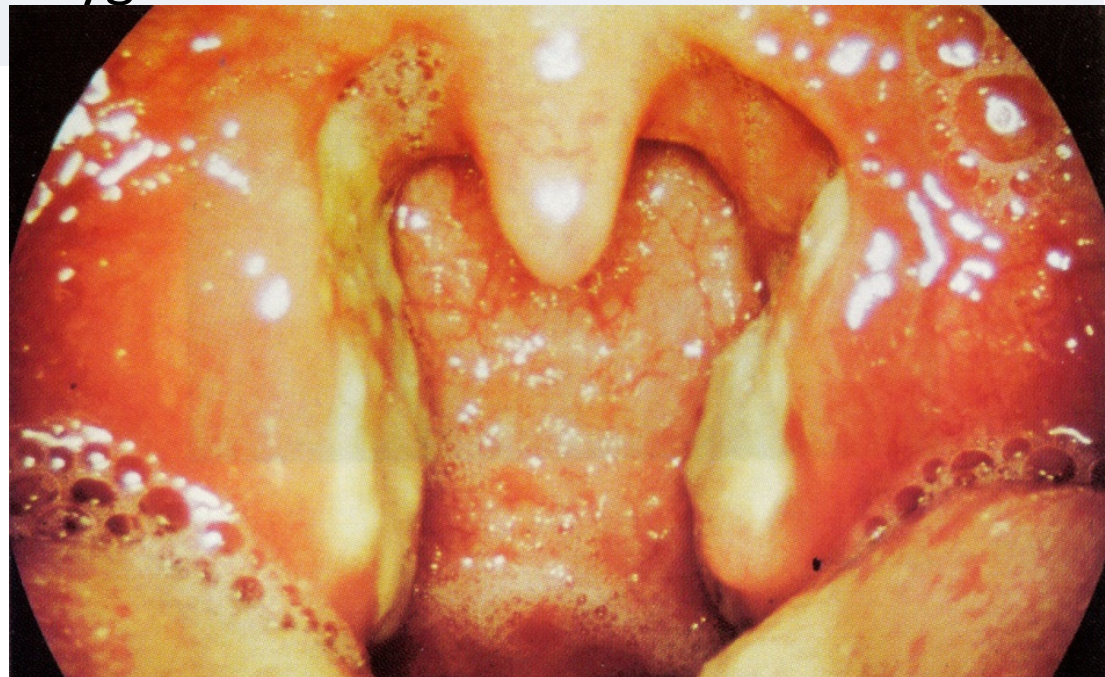
Malgré une pénicillinothérapie d'une semaine, un homme de 24 ans présente toujours une odynophagie persistante associée à une asthénie et à une polyadénopathie cervicale bilatérale.

Au vu du status pharyngé (voir figure), quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

- A. une tuberculose pharyngée
- B. une angine de Plaut-Vincent
- C. une mononucléose infectieuse
- D. une angine herpétique
- E. une pharyngite virale



A.	une tuberculose pharyngée : contexte exposition (migrants ou exposition famille, immunodépression, par ex HIV, antiTNF)
B.	une angine de Plaut-Vincent: ulcéreuse ou ulcéro-nécrotique, due à l'association fuso-spirillaire. État dentaire précaire
C.	une mononucléose infectieuse : âge, aspect érythémato-pultacée, fausses membranes, péni inefficace (rash possible)
D.	une angine herpétique: vésicules et pas de fausses membranes
E.	une pharyngite virale: amygdales atteintes



11. Un toxicomane HIV-positif de 35 ans vous consulte pour une tuméfaction latéro-cervicale non-douloureuse. Vous constatez une tuméfaction érythémateuse de 4 cm de diamètre, dont la palpation est peu douloureuse mais fluctuante. Quel est le diagnostic le plus probable?

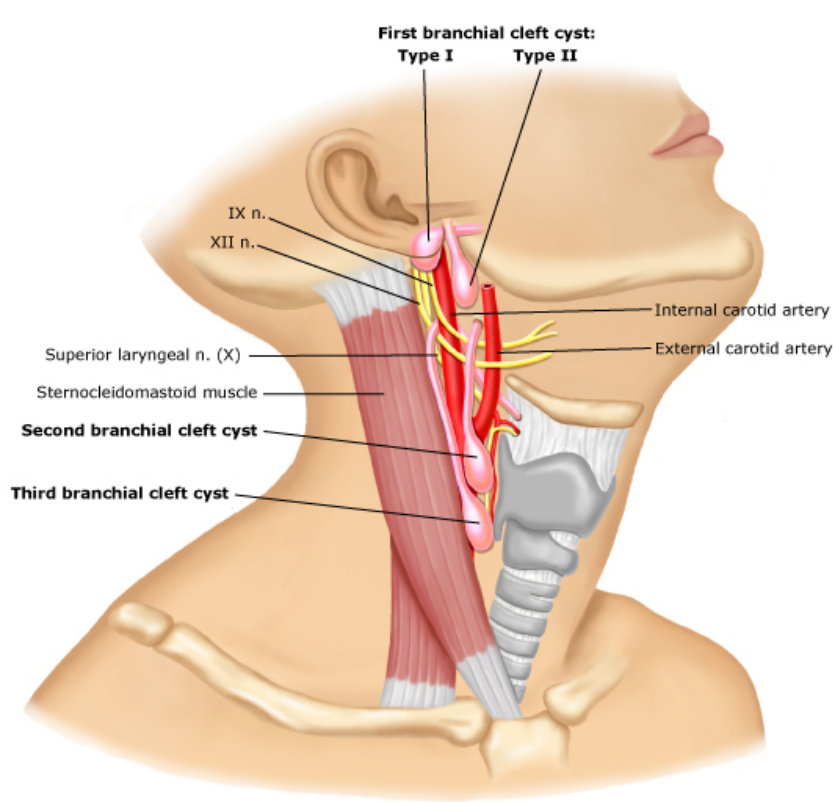
- | | |
|-----------|-------------------------------|
| A. | un kyste thyroïdien |
| B. | un kyste branchiogène |
| C. | un lymphome malin |
| D. | une tuberculose ganglionnaire |

Un toxicomane HIV-positif de 35 ans vous consulte pour une tuméfaction latéro-cervicale non-douloureuse. Vous constatez une tuméfaction érythémateuse de 4 cm de diamètre, dont la palpation est peu douloureuse mais fluctuante. Quel est le diagnostic le plus probable?

- | | |
|-----------|---|
| A. | un kyste thyroïdien: non inflammatoire, région thyroïdienne |
| B. | un kyste branchiogène: non inflammatoire |
| C. | un lymphome malin: plus souvent dur, non fluctuant |
| D. | une tuberculose ganglionnaire: contexte HIV, peu de douleur (différent adénite suppurée staphylocoque par ex) |

HIV <__> TBC

Non indurée, érythémateuse : TBC



Kyste branchiogène :

- ✓ Anomalie du développement congénital
- ✓ Le plus souvent médiastinal et thoracique
- ✓ Rare et encore plus au niveau cervical ...

12. Une femme de 28 ans consulte pour une sensation de mains froides douloureuses. Cette sensation intermittente survient lorsque ses mains sont exposées au froid et l'a beaucoup gênée l'hiver dernier. Un ulcère digital de l'index gauche est survenu lors d'une semaine de ski et a pris 4 semaines pour cicatriser. Elle fume depuis 10 ans (10UPA). Elle prend une contraception orale de 2nd génération. Elle n'a pas d'antécédent personnel et sa mère qu'elle n'a pas connu aurait eu un problème similaire. Elle vous montre une photo de ses mains lors du phénomène en question. Quel élément est inhabituel pour une origine idiopathique ?

- | | |
|-----------|------------------------|
| A. | L'âge jeune |
| B. | L'antécédent maternel |
| C. | L'ulcère digital |
| D. | Le tabagisme |
| E. | La contraception orale |



Une femme de 28 ans consulte pour une sensation de mains froides douloureuses. Cette sensation intermittente survient lorsque ses mains sont exposées au froid et l'a beaucoup gênée l'hiver dernier. Un ulcère digital de l'index gauche est survenu lors d'une semaine de ski et a pris 4 semaines pour cicatriser. Elle fume depuis 10 ans (10UPA). Elle prend une contraception orale de 2nd génération. Elle n'a pas d'antécédent personnel et sa mère qu'elle n'a pas connu aurait eu un problème similaire. Elle vous montre une photo de ses mains lors du phénomène en question. Quel élément est inhabituel pour une origine idiopathique ?

- | | |
|----|------------------------|
| A. | L'âge jeune |
| B. | L'antécédent maternel |
| C. | L'ulcère digital |
| D. | Le tabagisme |
| E. | La contraception orale |



Maladie de Raynaud : souvent 15-30 ans, contexte familial, femme

- Symmetric episodic attacks
- No evidence of peripheral vascular disease
- No tissue gangrene, digital pitting, or tissue injury
- Negative nailfold capillary examination
- Negative antinuclear antibody test and normal ESR (VS)



Phase blanche,
syncopale = crise



Phase bleue,
cyanotique

Puis phase chaude/
rouge, douloureuse

Raynaud secondaire: « connectivite », vasculite, ergotisme, engins vibrant. Rechercher atypie : ulcère, âge, homme.

13. Un homme de 65 ans s'est présenté aux urgences pour une douleur du mollet gauche et une dyspnée aiguë. Une échographie à montrer une thrombose complète de la veine fémorale superficielle gauche d'aspect récent. L'examen clinique est normal en dehors d'un œdème douloureux du mollet gauche.

L'étape suivant la plus pertinente est :

- | | |
|----|------------------------------------|
| A. | Un angioCT scan pulmonaire |
| B. | Acénocoumarol 2 mg PO |
| C. | Alitement strict |
| D. | Enoxaparine 1mg/kg SC |
| E. | Alteplase, rt-PA 100 mg IV sur 2 h |

Un homme de 65 ans s'est présenté aux urgences pour une douleur du mollet gauche et une dyspnée aiguë. Une échographie a montré une thrombose complète de la veine fémorale superficielle gauche d'aspect récent. L'examen clinique est normal en dehors d'un œdème douloureux du mollet gauche.

L'étape suivante la plus pertinente est :

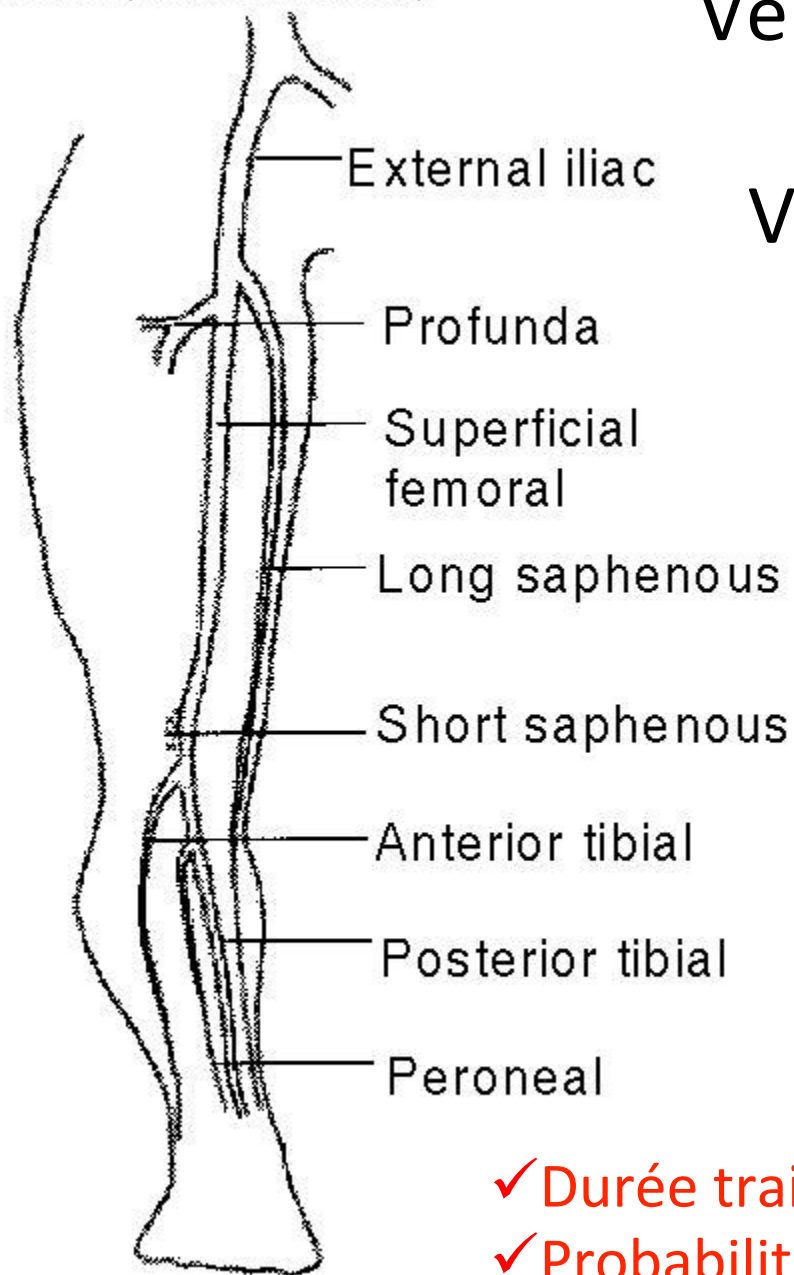
- | | |
|----|------------------------------------|
| A. | Un angioCT scan pulmonaire |
| B. | Acénocoumarol 2 mg PO |
| C. | Alitement strict |
| D. | Enoxaparine 1mg/kg SC |
| E. | Alteplase, rt-PA 100 mg IV sur 2 h |

Pourquoi HBPM ?

A.	Un angioCT scan pulmonaire : TVP déjà diagnostiquée, examen clinique RAS, même traitement
B.	Acénocoumarol 2 mg PO: action lente, effet procoagulant initial (PC-PS baissent avant FII)
C.	Alitement strict: histoire ancienne ... cf traitement ambulatoire EP
D.	Enoxaparin 1mg/kg SC: anticoagulation rapide indispensable. Fondaparinux, HNF ou Rivaroxaban PO aussi justes.
E.	Alteplase, rt-PA 100 mg IV sur 2 h: EP massive seulement

Si HD instable
~AVC

Veine fémorale superficielle = Veine « profonde » (TVP)



- ✓ Durée traitement à connaitre 3 mois, à prolonger?
- ✓ Probabilité clinique avant tout
- ✓ TVP et EP non massive: même traitement

Si EP massive rtPA

14. Lors d'un don du sang, des antigènes HBs et HBe sont détectés chez un père de famille.
Quelle est la première mesure à prendre?

A.	une immunisation active contre l'hépatite B des autres membres de la famille
B.	une immunisation active et passive contre l'hépatite B des autres membres de la famille
C.	une immunisation passive de l'épouse contre l'hépatite B
D.	une recherche des anticorps et des antigènes de l'hépatite B par un examen de sang des autres membres du même ménage
E.	aucune mesure n'est à prendre, car cet état de porteur est probablement ancien

Lors d'un don du sang, des antigènes HBs et HBe sont détectés chez un père de famille. Il s'agit apparemment d'un porteur infectieux de l'hépatite B.

Quelle est la première mesure que doit prendre le médecin de famille?

A.	une immunisation active contre l'hépatite B des autres membres de la famille
B.	une immunisation active et passive contre l'hépatite B des autres membres de la famille
C.	une immunisation passive de l'épouse contre l'hépatite B
D.	une recherche des anticorps et des antigènes de l'hépatite B par un examen de sang des autres membres du même ménage
E.	aucune mesure n'est à prendre, car cet état de porteur est probablement ancien

- use a latex condom with every **sexual encounter**.
- Do not share razors, toothbrushes, or **anything that has blood on it**.
- Immediate family and household members should be tested for hepatitis B. Anyone who is at risk of hepatitis B infection should be vaccinated.**
- Do not share any injection drug equipment (needles, syringes).
- Clean blood spills with **bleach** (1/9)

Hepatitis B **cannot** be spread by:

- Hugging or kissing
- Sharing eating utensils or cups
- Sneezing or coughing toux, eternuant
- Breastfeeding

15. Une patiente de 58 ans se présente pour une douleur abdominale, en hémi-ceinture droite au niveau épigastrique. La douleur est apparue le matin et s'est aggravée dans la journée. Il n'y pas de trouble du transit. La patiente a un antécédent d'appendicectomie. Les paramètres vitaux sont dans la norme et l'examen abdominal montre une sensibilité superficielle sans défense ni autre anomalie. La biologie ne montre pas d'anomalie des tests hépatiques, la lipase est normale et une échographie est normale avec une vésicule alithiasique à parois fines.

Parmi les suivants le diagnostic le plus probable est:

A.	Cholécystite alithiasique
B.	Pancreatite aiguë
C.	Diverticulite caecale
D.	Zona abdominal
E.	Ulcère gastrique

Une patiente de 58 ans se présente pour une douleur abdominale, en **hémi-ceinture** droite au niveau épigastrique. La douleur est apparue le matin et s'est aggravée dans la journée. La douleur est décrite comme une **brûlure**. Il n'y a pas de trouble du transit. La patiente a un antécédent d'appendicectomie.

Les paramètres vitaux sont dans la norme et l'examen abdominal montre une sensibilité superficielle, avec **hyperpathie cutanée**, sans défense ni autre anomalie.

La biologie ne montre pas d'anomalie des tests hépatiques, la lipase est normale et une échographie est normale avec une vésicule biliaire lithiasique à parois fines.

Parmi les suivants le diagnostic le plus probable est:

A. Cholécystite

B. Pancreatite aiguë

C. Diverticulite caecale

D. Zona abdominal

Douleurs avant l'éruption !!

E. Ulcère gastrique



3Y1027 [RM] © www.visualphotos.com

Douleurs abdominales pièges

- ✓ Radiculaire : trajet, unilatérale. Ex : VZV (douleur avant l'éruption), Lyme, compression racine
- ✓ Projetée: Infarctus myocarde
- ✓ Autres :

intox plomb: contexte expo, enfant

FMF: pourtour méditerranée, crises fièvre méditerranéenne familiale

HPN (hémoglobinurie paroxystique nocturne): crises, hémoglobinurie
macrohématurie

16. Une femme de 23 ans consulte en urgence pour des palpitations. Elle décrit deux épisodes similaires antérieurs. Elle n'a pas d'antécédent et ne prend aucun traitement.

T=37.2°C, PAH=112/68 mmHg, FC=142/min au repos, FR=20/min.
bruits du cœur régulier, pas de souffle, auscultation pulmonaire normale.

ECG: Tachycardie supraventriculaire paroxystique.

Le traitement à réaliser en priorité est:

A.	Héparine
B.	Digoxine iV
C.	Massage du sinus carotidien
D.	Cardioversion électrique
E.	Metoprolol IV

Une femme de 23 ans consulte en urgence pour des palpitations. Elle décrit deux épisodes similaires antérieurs. Elle n'a pas d'antécédent et ne prend aucun traitement.

T=37.2°C, PAH=112/68 mmHg, FC=142/min au repos, FR=20/min. bruits du cœur régulier, pas de souffle, auscultation pulmonaire normale.

ECG: Tachycardie supraventriculaire paroxystique.

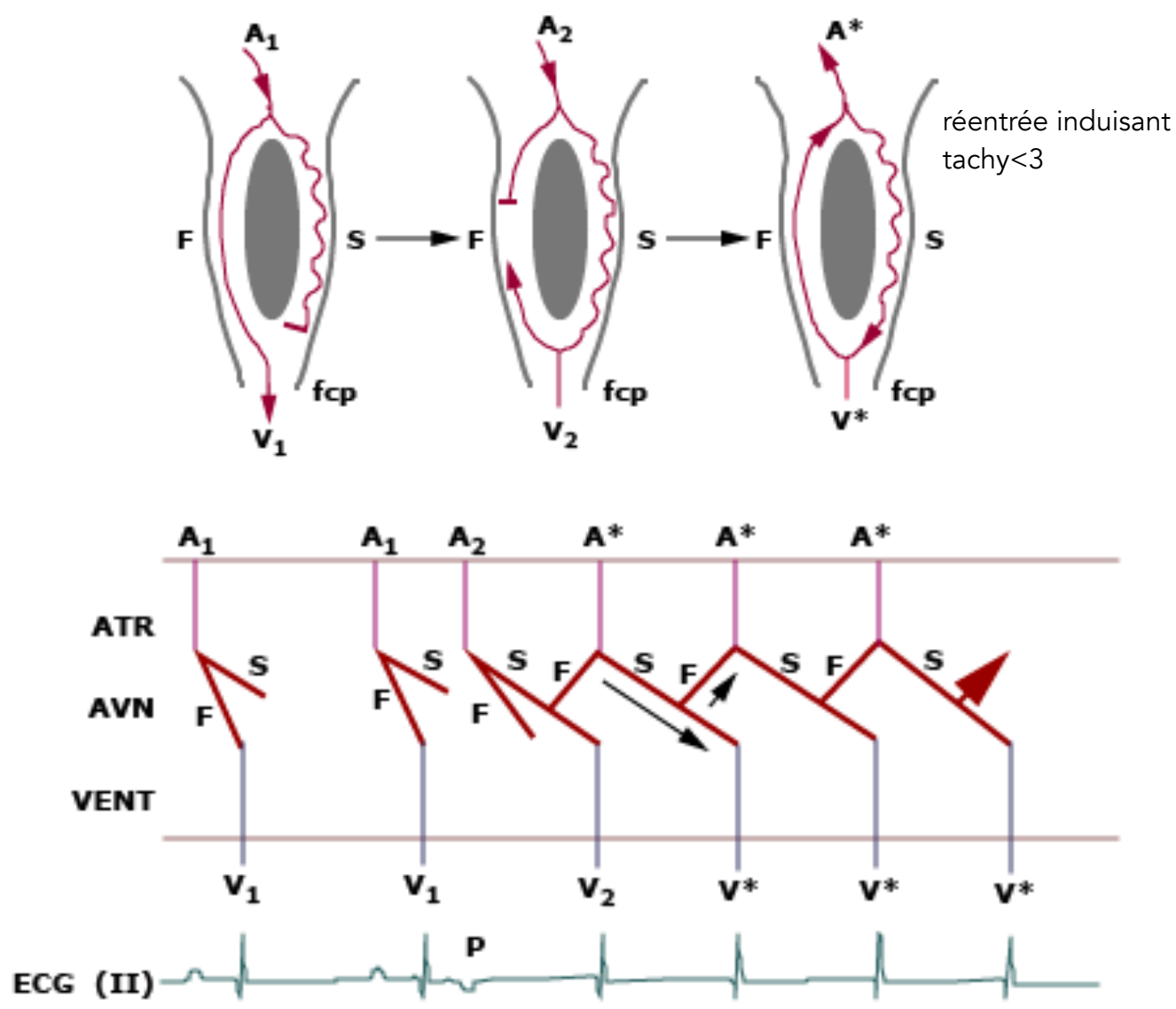
Le traitement à réaliser en priorité est:

A.	Héparine
B.	Digoxine IV
C.	Massage du sinus carotidien
D.	Cardioversion électrique
E.	Metoprolol IV

Pourquoi le massage ?

A.	^{supraventriculaire !} Héparine : TSVP n'est pas une arythmie, pas de stase ≠ FA
B.	Digoxine IV : rarement utilisé. Plutôt Adénosine, Calcium -, béta- en deuxième intention
C.	Massage du sinus carotidien ^{les MI en l'air, Valsalva} Manœuvre vagale, ↑ para Σ , ↓ conduction. Vérifier absence de souffle avant.
D.	Cardioversion électrique: seulement si hémodynamiquement instable
E.	Metoprolol IV: si Adénosine, Calcium - inefficace

AVNRT atrioventricular nodal reentrant tachycardia



17. Un homme de 72 ans, est hospitalisé pour un ulcère malléolaire droit évoluant depuis 2 mois et ne cicatrisant pas. L'ulcère mesure 2x3cm, est douloureux et fibrineux. Il existe un œdème des membres inférieurs rendant l'examen vasculaire difficile. Tabagisme actif à 100UPA. Antécédent de STEMI, de pontage aorto-coronaire et insuffisance cardiaque. L'examen de la peau et le reste de l'examen clinique sont sans particularités. Quel examen réalisé en priorité ?

A.	Une échographie doppler artérielle des MI
B.	Une échographie doppler veineuse des MI
C.	Une radiographie de la cheville F+P
D.	Une biopsie de peau
E.	Un dosage du BNP

Un homme de 72 ans, est hospitalisé pour un ulcère malléolaire droit évoluant depuis 2 mois et ne cicatrisant pas. L'ulcère mesure 2x3cm, est douloureux et fibrineux. Il existe un œdème des membres inférieurs rendant l'examen vasculaire difficile.

Tabagisme actif à 100UPA. Antécédent de STEMI, de pontage aorto-coronaire et insuffisance cardiaque. L'examen de la peau et le reste de l'examen clinique sont sans particularités.

Quel examen réalisé en priorité ?

FRCV : atteinte artérielle. douloureux

A.	Une échographie doppler artérielle des MI
B.	Une échographie doppler veineuse des MI
C.	Une radiographie de la cheville F+P
D.	Une biopsie de peau
E.	Un dosage du BNP

Oedème :

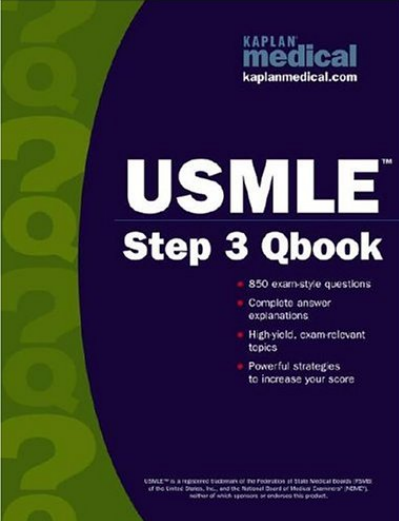
MI en déclive ++, inflammation, IC

A.	Une échographie doppler artérielle des MI : vasculaire, tabac, douleur
B.	Une échographie doppler veineuse des MI: si orientation par dermite ocre, varices, atcd MTEV
C.	Une radiographie de la cheville F+P: si contact osseux, suspccion osteite si contact osseux / si suspicion
D.	Une biopsie de peau: si suspicion de vasculite si vasculite?
E.	Un dosage du BNP: ??

Ulcères

- ✓ **Veineux** : stase, sus-malléolaire, peu douloureux, hyperpigmentation, pouls présents
- ✓ **Artériel**: peri-malléole, bords nets, nécrose possible, pas de bourgeonnement, pas de pouls, IPS
- ✓ Mixte ! Dans la pratique ...
- ✓ Autres => biopsie +++
 - angiodermite nécrosante: aigu et noir, bilat
 - pas ds le SclO cryoglobuline : penser HCV
 - vasculite (par ex: MPA): autres signes
 - tumoral malin

Indice de pression
systolique



United States Medical Licensi... x

www.usmle.org/practice-materials/

3LUC VOTRE PORTAIL INTR...

Examination UNITED STATES MEDICAL LICENSING EXAMINATION

Home Bulletin FAQs Apply Step 1 Step 2 CK Step 2 CS Step 3 Practice Materials Scores & Transcripts Test Accommodations Security

Download Menu Instructions Step 3 CCS Case Studies Feedback Support

Practice Materials

Practice Materials

Download Menu

Please note: Macintosh (Mac) and Linux are not supported.

Step 1

- [Step 1 Content Description and General Information Booklet](#)
- [Tutorial and Practice Test Items for Multiple Choice Questions*](#) download 22 Mb

Step 2 Clinical Knowledge (CK)

- [Step 2 CK Content Description and General Information Booklet](#)
- [Tutorial and Practice Test Items for Multiple Choice Questions*](#) download 23 Mb

Step 2 Clinical Skills (CS)

Instructions

- [About the Software](#)
- [Installing the Software](#)
- [Using the Software](#)
- [Get Technical Support](#)

Special Note About Tutorials

Tutorials are optional on the day of the examination. It is very important, however, to use the tutorial to check for headphone volume even if you skip all other parts of the tutorials.

Démarrer 2013 Microsoft Excel 2011 DECL... Boîte de réce... Microsoft Po... 08_QCM EFM... United Stat... 18:54

<http://www.usmle.org/practice-materials/>

L'un de vos collègues a été chargé d'enquêter sur l'origine d'une épidémie d'intoxications alimentaires survenues parmi les 48 personnes ayant participé à un pique-nique. Il vous présente le tableau suivant des données qu'il a récolté: Quelle est la source la plus probable de l'épidémie?

	Personnes ayant mangé l'aliment en question		Personnes n'ayant pas mangé l'aliment en question	
	Total	Tombés malades	Total	Tombés malades
Crevettes	12	8	36	15
Poulet froid	18	17	30	3
Salade russe	25	12	23	12
Salad grecque	37	17	11	8
Crème vanille	46	22	2	1

- A. les crevettes
- B. le poulet froid
- C. la salade russe
- D. la salade grecque
- E. la crème vanille

L'un de vos collègues a été chargé d'enquêter sur l'origine d'une épidémie d'intoxications alimentaires survenues parmi les 48 personnes ayant participé à un pique-nique. Il vous présente le tableau suivant des données qu'il a récolté: Quelle est la source la plus probable de l'épidémie?

	Personnes ayant mangé l'aliment en question		Personnes n'ayant pas mangé l'aliment en question		OR
	Total	Tombés malades	Total	Tombés malades	
Crevettes	12	8	36	15	2.8
Poulet froid	18	17	30	3	153
Salade russe	25	12	23	12	0.8
Salad grecque	37	17	11	8	0.3
Crème vanille	46	22	2	1	0.9

- A. les crevettes
- B. le poulet froid
- C. la salade russe
- D. la salade grecque
- E. la crème vanille

Pourquoi le poulet ?

	Personnes ayant mangé l'aliment en question		Personnes n'ayant pas mangé l'aliment en question		OR
	Total	Tombés malades	Total	Tombés malades	
Crevettes	12	8	36	15	2.8
Poulet froid	18	17	30	3	153
Salade russe	25	12	23	12	0.8
Salad grecque	37	17	11	8	0.3
Crème vanille	46	22	2	1	0.9

Poulet froid	Non exposés Expo -	Exposés Expo +
Non malade. M -	A=27	B=1
Malades: M+	C=3	D=17

$$OR = A \times D / B \times C = 27 \times 17 / 1 \times 3 = 153$$

- Un homme âgé de 35 ans tombe de cheval sans perte de connaissance, et présente des céphalées modérées. Dix jours plus tard, un état confusionnel et une hémiplégie apparaissent en l'espace de 24 heures.
- Quel est le diagnostic le plus probable?

A.	un hématome épidural
B.	un accident vasculaire cérébral
C.	une méningo-encéphalite après une fracture du crâne non diagnostiquée
D.	un hématome sous-dural
E.	une thrombose du sinus veineux

- Un homme âgé de 35 ans tombe de cheval sans perte de connaissance, et présente des céphalées modérées. Dix jours plus tard, un état confusionnel et une hémiparésie apparaissent en l'espace de 24 heures.
- Quel est le diagnostic le plus probable?

A.	un hématome épidural
B.	un accident vasculaire cérébral
C.	une méningo-encéphalite après une fracture du crâne non diagnostiquée
D.	un hématome sous-dural
E.	une thrombose du sinus veineux

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A. un hématome épidural
- aigu

B. un accident vasculaire cérébral
- Âge et FR contre, histoire contre

C. une méningo-encéphalite après une fracture du crâne non diagnostiquée
- Clinique contre, 0 EF

D. un hématome sous-dural
- Complication retardée d'un traumatisme

E. une thrombose du sinus veineux
- céphalées, troubles neurologiques plus insidieux, mais diagnostic difficile...

- Un patient de 80 ans ayant subi une cholécystectomie des années en arrière, en mauvais état général et ictérique, se plaint de coliques dans l'hypocondre droit.
- L'examen radiologique révèle une concrétion radio-opaque d'environ 1 cm dans la région prépapillaire du cholédoque.
- Quel est le meilleur traitement chez ce patient?

A.	aucun traitement à part un régime pauvre en graisses
B.	des analgésiques et des spasmolytiques
C.	une dissolution médicamenteuse du calcul par l'acide ursodésoxycholique
D.	une révision chirurgicale des voies biliaires
E.	une papillotomie sous endoscopie avec extraction du calcul

- Un patient de 80 ans ayant subi une cholécystectomie des années en arrière, en mauvais état général et ictérique, se plaint de coliques dans l'hypocondre droit.
- L'examen radiologique révèle une concrétion radio-opaque d'environ 1 cm dans la région prépapillaire du cholédoque.
- Quel est le meilleur traitement chez ce patient?

A.	aucun traitement à part un régime pauvre en graisses
B.	des analgésiques et des spasmolytiques
C.	une dissolution médicamenteuse du calcul par l'acide ursodésoxycholique
D.	une révision chirurgicale des voies biliaires
E.	une papillotomie sous endoscopie avec extraction du calcul

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	aucun traitement à part un régime pauvre en graisses - inefficace
B.	des analgésiques et des spasmolytiques - oui, mais symptomatique seul
C.	une dissolution médicamenteuse du calcul par l'acide ursodésoxycholique - Pas efficace
D.	une révision chirurgicale des voies biliaires - Ok mais patient en mauvais état général, risque chir.
E.	une papillotomie sous endoscopie avec extraction du calcul - Le plus approprié